

Aceptación radical en DBT

Protocolo clínico para trabajar la no-aceptación

La aceptación radical es una de las habilidades más malentendidas de la DBT. No es resignación, no es aprobación y no es pasividad. Es reconocer la realidad tal como es — completamente, con todo el cuerpo — como primer paso para poder actuar sobre ella.

Aceptar no significa que esté bien lo que pasó. Significa dejar de pelear con el hecho de que pasó.

¿Qué es y qué no es la aceptación radical?

Aceptación radical ES...

- Reconocer la realidad tal como es
- Dejar de luchar contra lo que ya ocurrió
- Soltar el sufrimiento secundario (el dolor por el dolor)
- El primer paso para actuar eficazmente
- Un acto activo y repetido — no pasivo
- Compatible con querer que las cosas cambien

Aceptación radical NO ES...

- Aprobar o justificar lo que pasó
- Resignarse a que las cosas sigan igual
- Olvidar o minimizar el sufrimiento
- Dejar de sentir dolor
- Rendirse o no hacer nada
- Algo que se logra una sola vez

Señales de no-aceptación en el paciente

Identificar antes de intervenir

- Rumiación repetitiva: "No debería haber pasado", "Es injusto"
- Rabia crónica ante situaciones que no puede cambiar
- Conductas de evitación del dolor (consumo, disociación, autolesión)
- "Si hubiera..." — revisión compulsiva del pasado
- Negación de hechos: negar la realidad de una pérdida, diagnóstico o ruptura
- Amargura sostenida que no disminuye con el tiempo

Protocolo de trabajo con aceptación radical

1

Identificar qué no se acepta

"¿Qué es lo que tu mente sigue rechazando?" Ser concreto: no "la vida", sino "que mi mamá murió" o "que me dejó". Cuanto más específico, mejor.

2

Explorar el costo de la no-aceptación

"¿Cuánta energía usás cada día peleando con eso? ¿Qué perdés? ¿Qué ganás?" La no-aceptación tiene función — a veces protege de la emoción de fondo.

3

Diferenciar el dolor del sufrimiento

El dolor es inevitable: la pérdida duele. El sufrimiento es opcional: es el dolor de no aceptar el dolor. Graficar esto con el paciente.

4

Practicar la aceptación radical en el cuerpo

No es solo cognitiva — es somática. Pedir que el paciente repita en voz alta: "Acepto que esto ocurrió". Observar la resistencia en el cuerpo. Trabajar con la respiración, la postura, la tensión.

5

Normalizar el proceso de ida y vuelta

La aceptación no es lineal. El paciente va a aceptar y luego volver a resistir. Cada vuelta a la aceptación es práctica, no fracaso. "Aceptar es un acto que hay que repetir, no una meta que se logra de una vez."

Frases terapéuticas útiles

“¿Qué pasaría si aceptaras completamente que eso ocurrió — solo por este momento?”

“La realidad no cambia porque no la aceptes. Lo que cambia es tu relación con ella.”

“¿Cuánto tiempo más querés gastar peleando con algo que ya pasó?”

“Aceptar no es para la otra persona — es para vos.”